CENTRE HOSPITALIER FICTIF DES PALOMBES
Pôle d'addictologie - CSAPA - 4, allée des Fictifs - 33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 00 31 52 60 Finess 33 0 99975 4

LASSUDRIE GREGOIRE Admission A2101180063
Né le 12/06/1979 (47 ans)
IPP 0107734528 UF 5140 - Addictologie
11 allée des Arbousiers, 33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Entretien téléphonique du 12/01/2021 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 12/01/2021 à 14:05
Appel de M. LASSUDRIE Grégoire, 41 ans, qui demande un RDV "pour la cocaïne, et un peu l'alcool aussi". Très poli, débit rapide, dit appeler depuis sa voiture entre deux clients. Explique que sa femme a trouvé "un sachet" dans sa veste juste avant Noël et lui a dit que c'était "la dernière fois". A reçu aussi un avertissement de son employeur en décembre (RDV client manqué). Pas de traitement en cours. Pas d'idées noires exprimées.
RDV médical donné le 18/01 à 17h30 avec le Dr DUCASSOU (il ne peut pas en journée). Tél : 06 58 21 77 43.

Observation médicale d'entrée du 18/01/2021 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 18/01/2021 à 20:12
Observations :
Première consultation. M. LASSUDRIE, 41 ans, cadre commercial (responsable grands comptes dans une société de distribution de matériel médical), marié, deux enfants, vient de lui-même sur l'insistance de son épouse. Arrive en costume, directement du travail, très à l'aise au début, un peu dans la séduction, puis plus touché quand on parle des enfants.

Motif : "Je veux arrêter la coke avant de tout perdre." Deux déclencheurs récents : son épouse a trouvé de la cocaïne dans sa veste à la mi-décembre et lui a posé un ultimatum ; avertissement écrit de son employeur en décembre 2020 pour un rendez-vous manqué avec un client important ("j'étais pas en état, j'avais fait la nuit"). Demande "quelque chose pour l'envie", et que sa femme ne soit pas mise au courant de tout.

Histoire de la consommation de cocaïne :
- Première prise vers 25 ans, en soirée, avec des amis de son ancienne équipe commerciale, "pour tenir la nuit". Usage festif ensuite, le week-end, une fois par mois puis presque tous les week-ends pendant plusieurs années, toujours sniffée, "jamais autrement", toujours en groupe.
- Changement net "il y a six ou sept ans", au moment de sa promotion comme cadre : usage en semaine, seul, pour "tenir le rythme" et "être brillant en rendez-vous". Prises dans la voiture ou aux toilettes avant les réunions. Impossibilité de s'arrêter une fois le sachet ouvert, consomme jusqu'à épuisement du produit, nuits blanches, "descentes" très pénibles le lendemain avec irritabilité et tristesse.
- Actuellement 3 à 4 g par semaine, 4 jours sur 7 environ, achetés par l'intermédiaire d'un contact, environ 70 euros le gramme. Maximum : "5 ou 6 g" sur un week-end.
- Arrêts : "deux ou trois fois quelques semaines", seul, sans aide. Dit n'avoir jamais consulté pour cela, ni psychiatre ni addictologue ("c'est la première fois que je parle de ça à quelqu'un").
- Jamais injectée, jamais fumée selon lui. Pas de partage de paille "depuis longtemps".
- Journée type d'un jour de consommation : première ligne vers 10 h dans la voiture avant le premier rendez-vous, puis toutes les deux heures environ, déjeuner client arrosé, retour tardif "pour que les enfants soient couchés", whisky pour dormir, 3 à 4 heures de sommeil. Les lendemains : fatigue, irritabilité, "je ne supporte personne", parfois arrêt de travail d'un jour qu'il dit "pour migraine".
- Budget : "entre 800 et 1 000 euros par mois", payés sur ses primes, "je gagne bien, ce n'est pas un problème d'argent". Pas de dette selon lui.
- Retentissement : tensions conjugales depuis plusieurs années, son épouse a découvert la cocaïne une première fois "il y a longtemps" et il avait promis d'arrêter ; il pense que son épouse "ne sait pas tout" sur les quantités. Il a conduit sous cocaïne et sous alcool "très souvent", jamais contrôlé, "pas d'accident".

Alcool : premières ivresses vers 15 ans. Consommation "sociale" importante dans le métier (repas d'affaires, salons). Depuis deux à trois ans, consommation quotidienne de 4 à 6 verres (vin, whisky le soir), davantage les soirs de cocaïne ("l'alcool pour redescendre"), jusqu'à une bouteille de vin et plusieurs whiskys. Pas de consommation matinale, pas de tremblements, pas d'antécédent de sevrage compliqué.

Tabac : depuis 16 ans, 15 à 20 cigarettes par jour, plus les soirs de cocaïne. Pas de tentative d'arrêt.
Cannabis : au lycée, arrêt vers 20 ans. Pas d'autre produit (ni MDMA, ni opiacés, ni médicaments détournés).
Jeu : "Je ne joue pas, à part un loto de temps en temps."

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Antécédents psychiatriques : aucun selon lui. Pas d'hospitalisation, pas de traitement psychotrope, pas de tentative de suicide. Décrit des périodes de "coup de mou" après les week-ends de consommation. Toujours été "speed", "j'ai besoin que ça bouge".
Antécédents somatiques : appendicectomie à 12 ans. Pas d'antécédent cardiaque, "jamais allé aux urgences de ma vie", pas d'épistaxis. Dit dormir 4 à 5 heures par nuit.
Antécédents familiaux : père "qui aimait bien les courses", pas d'alcoolisme connu. Pas d'antécédent psychiatrique familial connu.

Biographie : né à Pau, aîné de deux enfants (une sœur, Peggy, qui vit à Eysines). Parents séparés quand il avait 14 ans, "sans plus", il est resté avec sa mère. Scolarité "correcte", bac puis BTS commercial. Commercial dans plusieurs entreprises puis entré en 2006 dans l'entreprise actuelle, cadre depuis plusieurs années, bien payé, objectifs "énormes". Marié depuis 2009 avec Amandine, infirmière scolaire ; deux enfants, Victor 9 ans et Capucine 6 ans. Propriétaires d'une maison à Saint-Médard-en-Jalles. Pas d'antécédent judiciaire. Permis de conduire valide, roule beaucoup pour son travail (40 000 km/an).

Examen : bonne présentation, contact chaleureux, logorrhée modérée, discours cohérent. Humeur plutôt neutre, anxiété à l'évocation du couple. Pas d'idée suicidaire. Pas d'élément psychotique, pas d'épisode de persécution sous produit rapporté. TA 142/88, FC 92. Pas de lésion nasale visible à l'inspection simple.

Critères DSM-5 : trouble de l'usage de la cocaïne sévère (7 critères : perte de contrôle, envie persistante d'arrêter et échecs, temps passé, craving, retentissement professionnel, poursuite malgré les problèmes conjugaux, consommation en situation dangereuse au volant). Trouble de l'usage de l'alcool d'intensité moyenne (4 critères). Tabagisme.

Ce qu'il attend : "des outils", "un médicament si ça existe", "que ça reste entre nous vis-à-vis du travail". Inquiétude sur la confidentialité vis-à-vis de l'employeur (mutuelle d'entreprise) : rassuré. Il dit ne pas pouvoir envisager d'arrêt de travail ni d'hospitalisation, "on est en pleine période de renouvellement des contrats".

Entretien complémentaire sur le mode de vie : sport "avant", football en club jusqu'à 30 ans, plus rien depuis. Alimentation irrégulière, saute souvent le déjeuner les jours de consommation. Pas de traitement en cours, pas d'automédication par benzodiazépines ou somnifères, "parfois un Doliprane pour la tête". Pas d'allergie connue.
Facteurs de protection : enfants, épouse "qui ne lâche pas", emploi, absence d'antécédent judiciaire. Facteurs de vulnérabilité : pression professionnelle, déplacements fréquents avec nuits à l'hôtel, réseau d'amis consommateurs, accès facile au produit, revenus élevés.
Motivation : stade de la préparation selon Prochaska ; il a déjà supprimé une partie des contacts de son téléphone "hier soir". Il demande s'il existe "un traitement de substitution comme pour l'héroïne" : information donnée sur l'absence de traitement validé, sur l'intérêt des approches psychothérapeutiques et sur la gestion des descentes.
Conclusions :
Trouble de l'usage de la cocaïne sévère, usage d'alcool associé, tabagisme. Demande d'aide sincère mais très liée à l'ultimatum de l'épouse. Hyperactivité et impulsivité notées à l'entretien, à réévaluer à distance.
Projet : arrêt de la cocaïne, objectif de réduction de l'alcool (pas plus de 2 verres par jour, pas d'alcool les jours de semaine). Pas de traitement médicamenteux d'emblée. Bilan biologique (NFS, BHC, GGT, CDT, sérologies VIH/VHC/VHB), recherche urinaire de toxiques, ECG. Proposition de suivi psychologique (Mme POUDENX) et d'un entretien IDE. RDV dans 15 jours avec l'interne puis avec moi.

Observation IDE du 26/01/2021 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 26/01/2021 à 17:48
M. LASSUDRIE vu pour le bilan et un entretien. Très pressé, a pris sur sa pause déjeuner, téléphone qui sonne tout le temps, je lui ai demandé de le couper, il a bien rigolé. Prise de sang faite, urines remises : cocaïne positive (dit avoir consommé samedi). ECG fait : RAS d'après moi, transmis au médecin.
AUDIT 17. Il dit qu'il va "arrêter jeudi, c'est décidé, j'ai prévenu personne". Je lui ai expliqué les descentes, le sommeil, l'appétit qui revient. Numéros utiles donnés.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation psychiatrique de suivi du 02/02/2021 (Urgence : Bas)

Validé par BAYLET Théo - Interne le 02/02/2021 à 18:40

Observations :
Vu ce jour (interne, supervisé par le Dr DUCASSOU)
Rappel : TU cocaïne sévère depuis la promotion professionnelle, début de la cocaïne vers 23 ans en soirée, alcool 4-6 verres/j, tabac 15-20 cig/j.
Dit ne plus avoir consommé de cocaïne depuis jeudi 28/01. Craving important le soir et en voiture "aux endroits où j'achetais". Sommeil très perturbé les premières nuits, hypersomnie le week-end, irritabilité avec les enfants.
Alcool : 2-3 verres le soir, "pas plus".
Bilan : GGT 78, CDT normale, sérologies négatives. ECG normal, QTc 412.
Il a parlé de sa démarche à son épouse, qui "attend de voir". Au travail, personne n'est au courant. Il dit avoir moins d'appétit pour le travail et plus pour la nourriture.
Conclusions :
Arrêt de la cocaïne depuis le 28/01/2021.
Stratégies vis-à-vis du craving (trajets modifiés, numéro du contact supprimé : à faire).
Pas de traitement. RDV psychologue le 16/02. RDV 15 j.

Entretien psychologique du 16/02/2021 (Urgence : Bas)

Validé par POUDENX Héloïse - Psychologue le 17/02/2021 à 09:20

Premier entretien. M. Lassudrie arrive en avance, s'excuse de "faire perdre du temps", puis parle beaucoup et vite, saute d'un sujet à l'autre. Il décrit sa vie comme "une course permanente" : objectifs, primes, classement des commerciaux affiché chaque lundi. La cocaïne lui a permis pendant des années "d'être celui qu'on attend", drôle, infatigable.
Il parle de son épouse avec admiration et un peu de crainte ("elle, elle est droite"). Il dit avoir honte vis-à-vis de ses enfants, surtout de Victor, "qui commence à comprendre quand je suis bizarre".
Peu de choses sur son enfance : "rien de spécial, mes parents se sont séparés, mon père était souvent sur les routes". Il change de sujet quand j'évoque son père.
Il dit que l'arrêt "se passe bien", mais décrit des soirées où il ne sait pas quoi faire de lui-même, tourne en rond, "je mets le foot à la télé et je regarde mon téléphone".
Bonne alliance, demande de travail centrée sur "comprendre pourquoi j'ai besoin de toujours plus".
Proposition : entretiens tous les 15 jours.
Il dit aussi qu'il "ne s'est jamais posé", qu'il a toujours eu besoin de remplir chaque minute, déjà enfant.

Observation IDE du 02/03/2021 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 02/03/2021 à 18:10

RDV médical non honoré ce jour. Appel au patient : en séminaire à Toulouse, avait oublié de prévenir. RDV redonné le 16/03.

Observation psychiatrique de suivi du 16/03/2021 (Urgence : Bas)

Validé par BAYLET Théo - Interne le 16/03/2021 à 19:02

Observations :
Vu ce jour
Abstinent de cocaïne depuis 7 semaines, urines négatives. Craving en diminution, surtout le jeudi soir ("c'était le jour").
Alcool réduit : pas d'alcool en semaine "sauf exception", 3-4 verres le samedi.
Sommeil meilleur, 6 h par nuit. Ambiance plus détendue à la maison selon lui.
Au travail : "les chiffres baissent un peu, je suis moins rapide".
Il a repris la course à pied deux fois par semaine, "pour remplacer". Il a supprimé le numéro de son contact et changé d'itinéraire le jeudi.
Conclusions :
Poursuite de l'abstinence. Pas de traitement.
RDV avec le Dr DUCASSOU en avril (fin de mon semestre).

Observation psychiatrique de suivi du 20/04/2021 (Urgence : Bas)

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 20/04/2021 à 20:30
Observations :
Vu ce jour
Abstinence de cocaïne maintenue depuis le 28/01. Tabac inchangé, 15 cig/j. Alcool le week-end.
Se plaint de difficultés de concentration au travail, oublis, "je n'arrive plus à finir un dossier". Évoque l'idée que la cocaïne "l'aidait à se concentrer". À explorer à distance de l'arrêt.
Thymie correcte, pas d'idée noire.
Il rapporte une soirée professionnelle avec de l'alcool sans cocaïne, "première fois depuis des années", vécue comme une victoire. Le couple va "mieux", sorties en famille le week-end.
Conclusions :
Poursuite du suivi psychologique.
RDV 2 mois.

Entretien psychologique du 15/06/2021 (Urgence : Bas)

Validé par POUDENX Héloïse - Psychologue le 15/06/2021 à 18:50
Séance centrée sur le travail. M. Lassudrie a "raté" son trimestre, son manager lui a fait une remarque devant l'équipe. Colère, puis effondrement : "sans la coke je suis un commercial moyen". Il fait le lien avec le besoin de reconnaissance, l'idée qu'il ne vaut que par ses résultats.
Il évoque les vacances d'août au Cap Ferret avec des amis "qui consomment" et dit qu'il a "peur et envie à la fois".
Travail sur un plan pour les vacances (qui prévenir, comment partir d'une soirée).

Observation psychiatrique de suivi du 07/09/2021 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 07/09/2021 à 20:05
Observations :
Vu ce jour
Rechute de cocaïne pendant les vacances, "vers le 15 août", au Cap Ferret, lors d'une soirée arrosée chez des amis : "une trace, puis toute la nuit". Plusieurs prises pendant la semaine suivante. Depuis la rentrée, "une ou deux fois" le week-end, environ 1 g à chaque fois. Rien au travail selon lui.
Alcool : binge les soirs de cocaïne (vin puis whisky), sinon 1-2 verres.
L'épouse n'est pas au courant de la reprise. Culpabilité ++.
Il dit avoir "baissé la garde" après six mois sans produit : "je pensais que j'étais guéri". La soirée s'est faite chez un ancien collègue, le produit circulait, il n'a pas pu partir. Il a consommé ensuite seul deux soirs de la même semaine, "pour finir ce qu'on m'avait laissé".
Travail : pas d'impact pour l'instant.
Conclusions :
Rechute de la cocaïne mi-août 2021 après 6 mois et demi d'abstinence, usage de week-end depuis.
Analyse de la rechute. Le patient refuse d'en parler à son épouse "pour l'instant".
RDV 1 mois, IDE dans 15 jours.

Observation IDE du 21/09/2021 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 21/09/2021 à 17:55
Entretien IDE avec M. LASSUDRY. Urines positives cocaïne (samedi dernier, il le dit sans difficulté). Tension 138/86. Me parle surtout de la rentrée des enfants, Capucine est en CP, il est fier, a montré les photos. Fume toujours autant, 15-20/j, "pas le moment".

Observation psychiatrique de suivi du 09/11/2021 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 09/11/2021 à 19:40
Observations :
Vu ce jour
Usage de cocaïne stabilisé selon lui à 2-3 soirées par mois, toujours en week-end, 1 à 1,5 g. Alcool en binge ces soirs-là (jusqu'à 8-10 verres), sinon peu.
A fini par en parler à son épouse en octobre, "elle l'a mal pris mais elle reste".

Travail : objectifs à nouveau atteints. Sommeil 5 h.
Thymie : neutre, quelques "descentes" tristes le dimanche. Pas d'idée suicidaire. Sommeil court. Il trouve la psychothérapie utile, "je vois mieux les pièges".
Conclusions :
Usage festif de week-end, pas de reprise de l'usage en semaine.
Proposition d'intégrer le groupe de prévention de la rechute animé par M. GUICHENEY (éducateur) à partir de janvier : accepte.
RDV janvier.

Entretien téléphonique du 14/12/2021 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 14/12/2021 à 11:30
Appel du patient pour décaler son RDV psychologue (déplacement à Paris pour un salon). RDV redonné en janvier. Rien de particulier signalé.

Observation éducateur du 11/01/2022 (Urgence : Bas)

Validé par GUICHENEY Cyril - Éducateur spécialisé le 11/01/2022 à 16:30
Entretien d'accueil avant le groupe "prévention de la rechute" (8 séances de janvier à juin, le mardi soir).
M. LASSUDRIE se présente comme "pas tout à fait comme les autres, moi je bosse", puis rectifie en riant. Je lui explique le fonctionnement (confidentialité, présence, pas de jugement). Il dit consommer "un peu" le week-end, objectif "zéro en semaine, et réduire le reste".
Situations à risque citées : fins de mois avec les primes, déplacements à l'hôtel, matchs de foot entre collègues. Il dit adorer le foot, "je suis tous les championnats".
Inscrit, première séance le 18/01.

Observation psychiatrique de suivi du 08/02/2022 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 08/02/2022 à 20:15
Observations :
Synthèse après un an de suivi.
Rappel du parcours : M. LASSUDRIE, 42 ans, cadre commercial, marié, deux enfants. Cocaïne depuis l'âge de 25 ans (2004), festive pendant une dizaine d'années, puis usage en semaine, solitaire et professionnel depuis sa promotion de 2014, avec perte de contrôle ; 3 à 4 g par semaine à l'entrée en janvier 2021. Alcool associé (4-6 verres/j à l'entrée, binge les soirs de cocaïne). Tabac 15-20 cig/j depuis l'âge de 16 ans. Pas d'antécédent psychiatrique, pas de suivi antérieur.
Venu après un avertissement professionnel (décembre 2020) et l'ultimatum de son épouse.
Évolution sur l'année : arrêt de la cocaïne le 28/01/2021, abstinence de six mois et demi, rechute mi-août 2021 pendant les vacances, puis usage de week-end, 2 à 3 fois par mois, 1 à 1,5 g, avec binge d'alcool. Pas de reprise de l'usage professionnel. Réduction de l'alcool en semaine. Tabac inchangé.
Suivi psychologique régulier depuis février 2021 (Mme POUDENX), bonne alliance. Groupe de prévention de la rechute depuis janvier 2022, assidu aux trois premières séances.
Plainte persistante de difficultés de concentration, d'impatience, de désorganisation au travail, présentes "depuis toujours" mais masquées par la cocaïne selon lui. À explorer (TDAH ? effet de l'arrêt ?), pas d'évaluation formelle pour l'instant.
Thymie stable. Pas d'idée suicidaire. Couple fragile mais "ça tient".
Examen : TA 136/84. Pas d'épistaxis signalée.
Entourage : épouse informée depuis octobre de la rechute de l'été, soutien "à distance". Enfants scolarisés à Saint-Médard, Victor en CM2, Capucine en CP. Le patient décrit une vie "à cent à l'heure", sport abandonné, sommeil court (5 h), beaucoup de temps sur son téléphone le soir.
Biologie de janvier : GGT 52, CDT normale. Urines : positives deux fois sur cinq contrôles en 2021 (septembre, novembre).
Tabac : refuse encore d'aborder l'arrêt, "une chose à la fois".
Il n'évoque pas de difficulté financière ni d'autre conduite addictive (jeu non exploré en détail : "pronostics entre collègues"). Il souhaite à terme "un usage festif contrôlé", objectif que je ne valide pas mais que nous discutons : risques de reprise de l'usage professionnel, rappel des antécédents de perte de contrôle.
Conclusions :

TU cocaïne sévère en rémission partielle (usage de week-end). TU alcool d'intensité moyenne, amélioré. Tabagisme.
Poursuite du suivi mensuel, du groupe et de la psychothérapie. Aborder à nouveau le tabac.
RDV mars.

Entretien psychologique du 15/03/2022 (Urgence : Bas)

Validé par POUDENX Héloïse - Psychologue le 15/03/2022 à 18:55
M. Lassudrie arrive tendu : réorganisation annoncée dans son entreprise, un nouveau directeur régional "qui veut faire du chiffre". Il parle de sa peur d'être "mis au placard" à 42 ans.
Il dit consommer "beaucoup moins", seulement en soirée, mais reconnaît avoir pensé à "une petite trace" avant une réunion la semaine dernière, "pour la première fois depuis un an". Il ne l'a pas fait.
Il parle d'un sentiment de vide le soir, qu'il remplit "avec le téléphone, les matchs, les vidéos". Quand je l'interroge sur ce qu'il fait sur son téléphone, il répond "rien de spécial, des résultats, des vidéos".
Travail sur les signaux d'alerte et sur ce qu'il pourrait dire à son épouse quand il va mal. Il trouve le groupe "utile mais un peu scolaire".

Observation éducateur du 22/03/2022 (Urgence : Bas)

Validé par GUICHENEY Cyril - Éducateur spécialisé le 22/03/2022 à 22:10
Groupe n°5. M. LASSUDRIE présent, assez dissipé, beaucoup de blagues, coupe la parole. Sur le thème "les pensées permissives" il donne l'exemple de la "petite trace méritée après un gros contrat". Quand un participant parle de dettes, il se ferme et regarde son téléphone. Je lui en fais la remarque à la pause : "c'était le score du match".

Observation psychiatrique de suivi du 05/04/2022 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 05/04/2022 à 20:40
Observations :
RDV non honoré. Message laissé sur le répondeur. Pas de nouvelles du patient à 20h.
Conclusions :
Rappel par l'IDE demain.

Observation psychiatrique de suivi du 03/05/2022 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 03/05/2022 à 19:55
Observations :
Vu ce jour (RDV manqué d'avril : "réunion tardive")
Reprise d'un usage de cocaïne en semaine depuis début avril : soirées seul à l'hôtel lors de déplacements puis "le mardi et le jeudi", y compris au travail avant des rendez-vous. Estime à 3 g par semaine. Pression commerciale (réorganisation, nouveau directeur régional).
Alcool : 4-5 verres le soir, de nouveau quotidien.
Épistaxis répétées depuis quelques semaines, croûtes nasales.
Il dit que la reprise s'est faite "par paliers" : une prise à l'hôtel lors d'un séminaire début avril, puis une deuxième la semaine suivante "pour un rendez-vous important", puis l'habitude revenue. Il ne l'a pas dit à son épouse. Sommeil 4 h, perte d'appétit.
Conclusions :
Rechute d'un usage sévère depuis avril 2022.
Proposition d'arrêt de travail : refusée ("ce serait pire"). Consultation ORL demandée. Rappel des risques cardiovasculaires.
RDV dans 15 jours.

Observation éducateur du 14/06/2022 (Urgence : Bas)

Validé par GUICHENEY Cyril - Éducateur spécialisé le 14/06/2022 à 17:15
Entretien individuel de fin de groupe (il a manqué 3 séances sur 8).
Il dit que le groupe l'a aidé "à voir ses excuses". Il reconnaît avoir "replongé" depuis avril.
En fin d'entretien, à propos d'un autre participant qui fume du crack, il me dit à voix basse qu'il a "fait de la base" lui aussi, au printemps 2019, avec un collègue de l'époque : la cocaïne cuisinée et fumée à la pipe, "plusieurs week-ends de suite,

peut-être cinq ou six". Il a arrêté parce que "ça m'a fait peur, je n'ai jamais eu autant envie de recommencer tout de suite". Il n'en avait jamais parlé, "ni au docteur ni à ma femme", et me demande si c'est "grave que ce ne soit pas dans le dossier". Je lui dis que je le transmets au Dr DUCASSOU, il est d'accord.
Évoque aussi, en passant, les pronostics de foot avec les collègues, "on met des petits billets".
Proposition : poursuivre en individuel avec moi une fois par mois en plus du suivi médical. Accepte.
Il dit qu'il a "toujours aimé ce qui va vite et ce qui fait peur".

Observation psychiatrique de suivi du 28/06/2022 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 28/06/2022 à 20:20
Observations :
Vu ce jour
Usage de cocaïne en semaine persistant, 3 jours sur 7, "un peu moins depuis 15 jours". Alcool quotidien.
Consultation ORL le 20/06 : perforation de la cloison nasale d'environ 1 cm, soins locaux, arrêt impératif du sniff. Le patient est inquiet ("ça m'a calmé").
Reprise avec lui de l'usage de cocaïne fumée au printemps 2019 confié à M. GUICHENEY : le confirme, "cinq ou six week-ends", jamais depuis.
Il dit que le travail "devient compliqué", objectifs non atteints, sentiment d'être surveillé. Thymie : irritabilité, pas de tristesse marquée, pas d'idée suicidaire.
Conclusions :
Perforation septale. TU cocaïne sévère en rechute.
Proposition d'un sevrage hospitalier : refusé. Rappel de la réduction des risques (pas de partage de paille, sérum physiologique).
Courrier demandé au médecin traitant (Dr SAUBIAC) pour les antécédents.
RDV 15 jours.

Observation médicale du 12/07/2022 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 12/07/2022 à 18:00
Observations :
Courrier reçu ce jour du Dr SAUBIAC, médecin traitant, en réponse à ma demande :
- suivi du patient depuis 2008 ;
- "M. Lassudrie a consulté en 2015 le Dr ESTRABAUD, addictologue libéral à Bordeaux, à qui je l'avais adressé pour une consommation de cocaïne ; il a été suivi environ six mois et avait arrêté" ;
- en 2016, "état dépressif réactionnel après l'arrêt de la cocaïne", traité par paroxétine 20 mg pendant trois mois, bonne évolution ;
- pas d'autre antécédent notable, appendicectomie.

Revu brièvement avec le patient au téléphone : confirme le suivi de 2015 ("je l'avais zappé, ou j'avais pas envie d'en parler") et une abstinence "de huit mois à peu près" en 2015-2016. Minimise l'épisode de 2016 ("un coup de fatigue").
Conclusions :
Correction des antécédents : suivi addictologique libéral en 2015 avec abstinence de huit mois ; épisode dépressif en 2016 traité par paroxétine. Ces éléments avaient été niés à l'entrée.

Observation IDE du 13/09/2022 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 13/09/2022 à 18:35
Vu pour entretien, en retard d'une heure. Fatigué, amaigri (-5 kg depuis juin d'après notre balance). Urines positives cocaïne. Dit "3-4 jours par semaine, je sais". Absences au travail ces derniers temps, son chef l'a convoqué. Saignements de nez moins fréquents. Je lui reparle de l'hospitalisation, il dit "après la rentrée des enfants". Transmis au Dr DUCASSOU.

Observation psychiatrique de suivi du 04/10/2022 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 04/10/2022 à 20:10
Observations :
Vu ce jour

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Convoqué à un entretien préalable à licenciement le 29/09 : retards, absences non justifiées, chiffres en chute, "on m'a dit que je sentais l'alcool à une réunion". Attend la décision. Colère contre son directeur, peu de critique.
Cocaïne : 3-4 jours par semaine, 3 à 4 g. Alcool 5-6 verres/j.
Thymie : irritable, sommeil 4 h, pas d'idée suicidaire.
Épouse "à bout", parle de séparation.
Il reconnaît que des clients se sont plaints de rendez-vous annulés au dernier moment. Il parle de "complot" de son directeur, puis concède : "j'étais pas là, même quand j'étais là".
Conclusions :
TU cocaïne sévère, usage quotidien d'alcool.
Nouvelle proposition d'hospitalisation : "pas maintenant". Proposition d'un arrêt de travail : accepte un arrêt de 15 jours.
RDV 15 jours.

Observation psychiatrique de suivi du 22/11/2022 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 22/11/2022 à 19:30
Observations :
Vu ce jour
Licenciement notifié par courrier hier, 21/11/2022, pour insuffisance professionnelle. Préavis non effectué. Dit être "soulagé et terrifié". Inscription à Pôle emploi prévue.
Cocaïne : poursuite, 3 g par semaine environ. Alcool quotidien.
Projette de "se remettre en forme avant de chercher".
Il dit qu'il n'en a pas encore parlé à ses enfants. Son épouse, informée, "ne dit plus rien". Il évoque le besoin de "rentrer de l'argent vite", sans préciser.
Thymie : anxieuse, sommeil 4 h, pas d'idée suicidaire.
Conclusions :
Perte d'emploi. Orientation vers l'assistante sociale (Mme TRESSENS) pour les droits.
RDV 1 mois.

Entretien téléphonique du 13/12/2022 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 13/12/2022 à 10:45
Appel du patient, très tendu. Contrôlé par la gendarmerie samedi soir (10/12) au retour d'un repas : dépistage salivaire positif à la cocaïne et alcool à 0,6 g/L. Permis suspendu, il attend la décision de la préfecture (il parle de 6 mois).
"Comment je vais chercher du travail sans voiture." Me demande une attestation de suivi, je lui dis de la demander au Dr DUCASSOU à son RDV. Pas d'idées noires exprimées. Transmis.

Observation psychiatrique de suivi du 20/12/2022 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 20/12/2022 à 19:45
Observations :
Vu ce jour
Arrêté préfectoral reçu : suspension du permis de conduire pour 6 mois à compter du contrôle du 10/12/2022, restitution conditionnée à un avis favorable de la commission médicale et à des analyses. Attestation de suivi remise.
Le patient dit que le contrôle l'a "réveillé" : pas de cocaïne depuis, alcool "deux ou trois verres". Très anxieux, insomnie, ruminations sur l'argent ("le chômage, ce n'est pas mon salaire"), sans plus de précision. Tendu quand j'évoque son budget.
Pas d'idée suicidaire. Fêtes de fin d'année prévues chez sa sœur.
Conclusions :
Suspension de permis depuis le 10/12/2022. TU cocaïne sévère, abstinence de 10 jours.
RDV fin janvier, IDE disponible pendant les fêtes.

Entretien téléphonique du 17/01/2023 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 17/01/2023 à 13:20
Observations :
Appel de Mme LASSUDRIE Amandine, épouse du patient, qui demande à me parler. Information donnée sur le secret

médical : je l'écoute sans lui transmettre d'information sur le suivi.
Elle a découvert la semaine dernière, en cherchant un document pour Pôle emploi, des relevés bancaires d'un compte qu'elle ne connaissait pas et des courriers de relance de plusieurs organismes de crédit. Elle parle de "quatre crédits renouvelables au moins" et de virements réguliers vers des sites de paris sportifs en ligne, "des centaines d'euros par semaine, depuis des années". Elle dit qu'elle savait pour la cocaïne mais "pas ça", qu'il lui a menti "sur tout", et qu'elle va lui demander de quitter la maison.
Elle s'inquiète pour lui : "il dit que de toute façon il ne vaut rien". Je l'encourage à appeler le 15 en cas d'inquiétude immédiate et lui donne le numéro du 3114.
Conclusions :
Information d'un tiers : jeu d'argent (paris sportifs en ligne) et dettes cachées, jamais évoqués par le patient en deux ans de suivi.
RDV avancé avec le patient : appel au patient, vient le 24/01.

Observation psychiatrique de suivi du 24/01/2023 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 24/01/2023 à 20:45
Observations :
Vu ce jour, à ma demande après l'appel de son épouse.
Le patient arrive défait, mal rasé, s'excuse longuement. Il reconnaît d'emblée le jeu : "Je savais qu'un jour ça sortirait."
Histoire du jeu : paris sportifs en ligne depuis 2017, d'abord sur le foot "pour pimenter les matchs", avec des collègues, quelques dizaines d'euros. Augmentation progressive, puis nette au premier confinement en 2020 ("je n'avais plus que ça, et la coke"). Paris sur tous les sports, paris en direct, plusieurs comptes sur différents sites, la nuit. Mises de 200 à 500 euros, "des fois 2 000 sur un week-end". Chasse aux pertes, mensonges, emprunts. Gains importants au début ("j'ai touché 6 000 une fois, c'est ça qui m'a eu").
Lien avec la cocaïne : "les deux allaient ensemble", paris la nuit sous cocaïne, cocaïne pour "tenir" après les pertes.
Dettes : crédits renouvelables souscrits depuis 2019 à l'insu de son épouse, un prêt personnel, découvert. Il dit "une vingtaine de mille", sans pouvoir donner de chiffre précis.
ICJE : 21/27.
Situation : son épouse lui a demandé de partir, il a quitté la maison vendredi 20/01, hébergé chez sa sœur Peggy à Eysines. Voit les enfants le mercredi.
Cocaïne : reprise après les fêtes, 2 à 3 fois par semaine, "moins qu'avant faute d'argent". Alcool : 4-6 verres/j. Permis suspendu depuis décembre.
Thymie : tristesse marquée, honte, anhédonie, insomnie, perte d'appétit. Idées de mort passives ("ce serait plus simple pour tout le monde"), pas de projet, critiquées, facteurs de protection : enfants, sœur.
Il dit avoir caché le jeu "parce que la coke, au moins, vous saviez quoi en faire". Il décrit des nuits entières sur les applications, les résultats en direct, l'impossibilité de s'arrêter quand il perdait, les mensonges à son épouse (relevés détournés, compte ouvert dans une autre banque). Il pense que le jeu "a tout aggravé" au travail : manque de sommeil, retards, téléphone en réunion.
Il dit que les sites lui offraient des "bonus" et des "paris remboursés", qu'un conseiller VIP l'appelait quand il ne jouait plus pendant quelques jours. Il estime avoir perdu "plus de 60 000 euros" en cinq ans, gains déduits, sans certitude. Il n'a jamais joué au casino ni au PMU, "ça c'était mon père".
Conclusions :
Jeu d'argent pathologique (paris sportifs en ligne) sévère, révélé ce jour, avec endettement. TU cocaïne sévère, TU alcool. Symptomatologie dépressive.
RDV avec l'AS (Mme TRESSENS) dès la semaine prochaine pour les dettes. Information sur l'interdiction volontaire de jeux (ANJ). Numéro du 3114. Pas d'antidépresseur pour l'instant, réévaluation dans 15 jours. Psychologue maintenue.

Observation sociale du 31/01/2023 (Urgence : Bas)

Validé par TRESSENS Sabine - Assistante sociale le 02/02/2023 à 10:15
Entretien à la demande du Dr DUCASSOUX. M. LASSUDRIE arrive avec une pochette de courriers non ouverts "pour la première fois".
Situation administrative : licencié le 21/11/2022 (insuffisance professionnelle), inscrit à Pôle emploi, ARE ouverte (environ 3 100 €/mois), indemnité de licenciement en partie déjà utilisée ("pour boucher des trous").

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Logement : propriétaire avec son épouse d'une maison à Saint-Médard-en-Jalles, crédit immobilier en commun (1 150 €/mois). Hébergé depuis le 20/01 chez sa sœur, cherche un studio.
Endettement (premier recensement, à compléter) :
- 4 crédits renouvelables : 9 800 €, 7 200 €, 6 500 €, 4 900 € ;
- prêt personnel de 2021 : 8 300 € restant dû ;
- découvert : 1 400 € ;
soit environ 38 000 € hors crédit immobilier. Mensualités cumulées supérieures à 1 600 €.
Il me dit que son épouse "ne connaît pas la moitié des montants".
Permis de conduire suspendu (contrôle du 10/12/2022), en attente de la commission médicale.
Démarches proposées : demande d'interdiction volontaire de jeux auprès de l'ANJ (formulaire rempli avec lui ce jour), courriers aux organismes pour suspension, constitution d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France quand la situation de logement sera claire, information sur l'aide juridictionnelle en cas de procédure de séparation.
Prochain RDV dans 3 semaines avec tous les relevés.
Revenus : ARE seule ; son épouse assure seule le crédit immobilier depuis le départ du patient. Pension pour les enfants non encore fixée, il verse "ce qu'il peut".
Il a signé ce jour un mandat pour que je contacte la Banque de France si nécessaire.
Il me dit avoir aussi emprunté de l'argent à des collègues, remboursé depuis, et "jamais à la famille". Il refuse pour l'instant de contacter son épouse au sujet du budget commun.

Entretien psychologique du 14/02/2023 (Urgence : Bas)

Validé par POUDENX Héloïse - Psychologue le 14/02/2023 à 18:30
M. Lassudrie revient sur ces deux années pendant lesquelles il "jouait la comédie" ici aussi. Il dit qu'il avait plus honte du jeu que de la cocaïne : "la coke, c'est presque glamour dans mon milieu, le jeu c'est minable".
Il décrit le pari en direct comme "le seul moment où je ne pensais à rien" ; une excitation qu'il compare à la première trace.
Il pleure en parlant de Capucine qui lui a demandé pourquoi il "habitait chez tata".
Il parle pour la première fois de son père : "lui aussi aimait bien parier", puis s'arrête et dit qu'il n'a pas envie d'aller là aujourd'hui.
Pas d'idée suicidaire exprimée ce jour.

Observation psychiatrique de suivi du 07/03/2023 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 07/03/2023 à 20:00
Observations :
Vu ce jour
A emménagé le 01/03 dans un studio à Mérignac (Résidence Les Hortensias). Voit ses enfants un week-end sur deux chez sa sœur.
Thymie : tristesse quotidienne depuis janvier, anhédonie, aboulie, insomnie de milieu de nuit, perte de 6 kg, ruminations de culpabilité ; idées de mort passives intermittentes, sans projet. Plus de deux mois d'évolution malgré la diminution des consommations.
Jeu : plus de pari depuis fin janvier selon lui, interdiction ANJ en cours.
Cocaïne : 1 à 2 fois par semaine, "quand je suis seul le soir". Alcool 3-5 verres/j.
Il dit avoir honte de recevoir ses enfants dans un studio. Il passe ses journées "à rien", ne cherche pas encore de travail. Il a reçu la confirmation que sa demande d'interdiction de jeux est en cours d'instruction.
Conclusions :
Épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne depuis janvier 2023.
Introduction d'escitalopram 10 mg/j. 3114 rappelé. RDV 1 mois, IDE dans 15 jours.

Observation IDE du 21/03/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 21/03/2023 à 17:40
Entretien IDE. Dit prendre l'escitalopram "presque tous les jours", nausées les premiers jours. TA 131/82. Studio "triste mais calme". Rien d'autre de particulier. Rappel RDV médical du 11/04.

Observation psychiatrique de suivi du 11/04/2023 (Urgence : Bas)

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 11/04/2023 à 18:50
Observations :
Vu ce jour en urgence, au retour d'un passage aux urgences de notre établissement ce week-end, sorti de l'UHCD hier (CR des urgences à récupérer).
Le patient raconte une soirée seul dans son studio samedi, "beaucoup de coke et pas mal de whisky", après un appel difficile avec son épouse au sujet de la vente de la maison. Il a envoyé des messages à sa sœur, qui a appelé les secours. Il parle d'idées de mort "comme d'habitude, sans plus", "je ne voulais pas vraiment le faire", et dit ne pas avoir eu de projet précis. Il dit prendre l'escitalopram "régulièrement".
Sa sœur, présente à la fin de l'entretien avec son accord, dit qu'il lui avait écrit "pardon pour tout, je vais aller faire un tour sur le pont".
Thymie très basse, pleurs, désespoir, honte ; risque suicidaire jugé élevé dans le contexte (isolement, dettes, perte d'emploi, séparation, intoxications répétées).
Il décrit les jours précédents : nuits sans sommeil, paris "dans la tête" alors qu'il ne joue plus, cocaïne 3 soirs sur 7 depuis mars, whisky tous les soirs. Il se sent "un poids pour tout le monde". Il ne sait pas dire combien il a consommé samedi.
Examen : contact correct, ralentissement, pleurs, pas d'élément psychotique, pas de signe de sevrage à ce stade. TA 138/90, FC 96.
Conclusions :
Crise suicidaire au décours d'une intoxication cocaïne-alcool. EDC.
Hospitalisation proposée dans l'unité d'addictologie, acceptée : entrée directe ce jour. Sevrage de l'alcool (oxazépam selon protocole), arrêt de la cocaïne, surveillance du risque suicidaire.

Observation infirmière du 13/04/2023 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 14/04/2023 à 06:00 par SÉRÉ Jérôme
Nuit. Pt (LASUDRIE) reveille a 2h, ne trouve pas le sommeil, demande a parler. Dit avoir "tres envie" de coke, transpire, tachycarde 98. Parle de samedi : "j'avais les cles du scooter de mon voisin, j'allais au pont d'Aquitaine", sa soeur l'a appele avant. Pleure. Pas d'idee suicidaire actuelle exprimee, "ici ca va". Oxazepam 10mg en si besoin donne a 2h15. Dort a 3h. Transmis a l'equipe de jour et au medecin.

Observation médicale de suivi du 18/04/2023 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 18/04/2023 à 17:30
Observations :
J7 d'hospitalisation. Sevrage d'alcool sans complication, oxazépam en décroissance. Craving de cocaïne intense les premiers jours, en baisse. Dort mieux.
CR des urgences récupéré : arrivée le 09/04 à 1h40, alcoolémie 1,92 g/L, urines positives cocaïne ; idées suicidaires avec scénario rapportées aux urgences (pont d'Aquitaine), confirmées par le patient à l'IDE de nuit. Le CR indique aussi un arrêt de l'escitalopram depuis une quinzaine de jours : le patient le reconnaît finalement ("j'avais l'impression que ça ne servait à rien").
Pas d'idée suicidaire depuis l'entrée, plan de sécurité rédigé avec lui.
Substituts nicotiniques (patch 21 mg) bien tolérés.
Conclusions :
Reprise de l'escitalopram à 15 mg/j. Préparation de la sortie : suivi rapproché, psychologue, AS. Contact avec sa sœur pour l'hébergement les premiers jours.

Observation médicale de sortie du 27/04/2023 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 27/04/2023 à 12:30
Observations :
Hospitalisation du 11/04/2023 au 27/04/2023 dans l'unité d'addictologie, à la suite d'un passage aux urgences le 09/04 (intoxication cocaïne et alcool, crise suicidaire).
Sevrage de l'alcool sous oxazépam sans complication, arrêt le 21/04. Abstinence de cocaïne depuis le 09/04. Craving en nette baisse.
Thymie : amélioration partielle, sommeil réparateur, plus d'idée suicidaire, se projette (enfants, dossier de surendettement, recherche d'emploi). Plan de sécurité remis.

Tabac : patch 21 mg, 5 cig/j.
Entretien familial le 25/04 avec son épouse, à la demande du patient : elle ne souhaite pas reprendre la vie commune pour l'instant mais "reste là pour les enfants". Le patient l'accepte.
Bilan biologique de sortie : GGT 61, ASAT/ALAT normales, sérologies négatives.
Conclusions :
Sortie ce jour, hébergé quelques jours chez sa sœur puis retour au studio.
Traitement : escitalopram 15 mg/j, patch nicotinique 21 mg/24h.
Suivi : Dr DUCASSOU dans 15 jours, psychologue hebdomadaire pendant un mois, AS, IDE. Courrier au Dr SAUBIAC.

Entretien psychologique du 16/05/2023 (Urgence : Bas)

Validé par POUDENX Héloïse - Psychologue le 16/05/2023 à 18:45
Reprise après l'hospitalisation. M. Lassudrie est plus posé, parle moins vite. Il dit avoir "touché le fond sur ce pont, même si je n'y suis pas allé".
Il a reçu la confirmation de son interdiction de jeux (effective début mai) : "c'est bizarre, c'est un soulagement". Il a supprimé les applications de son téléphone devant sa sœur.
Travail sur la honte et sur la place des enfants. Il souhaite écrire une lettre à son épouse pour "tout dire, une fois".
Il demande que les séances restent hebdomadaires jusqu'à l'été.

Observation sociale du 13/06/2023 (Urgence : Bas)

Validé par TRESSENS Sabine - Assistante sociale le 15/06/2023 à 09:50
Entretien de suivi.
Dossier de surendettement déposé à la Banque de France le 08/06/2023 avec mon aide. Montant déclaré après relevés complets : 41 500 € de dettes non immobilières (deux créanciers supplémentaires retrouvés, dont un crédit en ligne).
Interdiction volontaire de jeux effective depuis le 02/05/2023 (courrier de l'ANJ apporté).
Séparation : pas de procédure de divorce engagée pour l'instant, "on fait une pause". La maison n'est finalement pas mise en vente.
En reprenant l'historique du prêt auto pour le dossier, M. LASSUDRIE me dit qu'en novembre 2020 il a "planté la voiture de fonction contre un muret" en rentrant d'une soirée sous cocaïne, sans blessé, et qu'il avait déclaré à l'assurance et à son employeur un "chevreuil sur la route". Il n'en avait jamais parlé ici. Je l'encourage à en parler au Dr DUCASSOU.
Permis : commission médicale le 27/06.
Prochain RDV en septembre (recevabilité).
Il dit aussi n'avoir "jamais rien déclaré à personne" et avoir payé lui-même les réparations du véhicule "en liquide".
Budget prévisionnel établi avec lui : ARE 3 100 €, loyer du studio 590 €, participation au crédit immobilier 575 €, pension pour les enfants 300 €, charges courantes ; reste à vivre insuffisant pour faire face aux mensualités des crédits.

Observation IDE du 27/06/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 27/06/2023 à 17:20
RDV IDE annulé par le patient ce matin : convocation à un atelier Pôle emploi. Reporté en juillet. Il dit au téléphone que "tout va bien, pas de rechute".

Observation psychiatrique de suivi du 11/07/2023 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 11/07/2023 à 20:15
Observations :
Vu ce jour
Abstinent de cocaïne depuis le 09/04 (3 mois), urines négatives à chaque contrôle. Alcool : 1 à 2 verres le week-end, rien en semaine. Pas de jeu.
Permis récupéré début juillet après avis favorable de la commission médicale.
Thymie : nette amélioration, sommeil correct, a repris le sport (course à pied), recherche d'emploi active.
Évoque l'accident de voiture de novembre 2020 sous cocaïne confié à l'AS : le confirme, "j'aurais pu tuer quelqu'un".
Tabac : 5-8 cig/j, patch arrêté fin juin.
Il a postulé à plusieurs offres, sans retour. Relation apaisée avec son épouse, ils se voient pour les enfants et "parlent vraiment".

Conclusions :
Rémission précoce cocaïne. EDC en amélioration. Escitalopram 15 mg poursuivi.
RDV septembre.

Entretien psychologique du 12/09/2023 (Urgence : Bas)

Validé par POUDENX Héloïse - Psychologue le 12/09/2023 à 18:40
M. Lassudrie annonce qu'il a commencé avec son épouse une thérapie de couple chez une conseillère conjugale en libéral, "une idée à elle". Première séance "très dure", elle a dit devant lui tout ce qu'elle avait découvert. Il dit qu'il a "enfin tout entendu sans fuir".
Il a passé l'été à courir, a perdu sa "panse de commercial", ne boit presque plus. Les enfants ont passé deux semaines avec lui chez sa sœur.
Il évoque à nouveau les difficultés de concentration, "maintenant que je suis clean je vois que ce n'était pas que la coke".
Il parle aussi de son père, malade et loin, avec qui il n'a "plus grand-chose à se dire".
Poursuite tous les 15 jours.

Observation sociale du 26/09/2023 (Urgence : Bas)

Validé par TRESSENS Sabine - Assistante sociale le 26/09/2023 à 11:00
Dossier de surendettement déclaré recevable par la commission le 14/09/2023. Suspension des poursuites. Orientation probable vers des mesures imposées (pas de bien saisissable hors résidence principale). M. LASSUDRIE est rassuré. Il dit avoir commencé avec son épouse une thérapie de couple en libéral ce mois-ci.
Prochain point au printemps ou à réception de la décision.

Entretien psychologique du 10/10/2023 (Urgence : Bas)

Validé par POUDENX Héloïse - Psychologue le 10/10/2023 à 19:05
Séance importante. M. Lassudrie revient de lui-même sur son père. Jean-Claude, représentant en vins, "toujours sur les routes", jouait : tiercé et quinté au PMU tous les jours, puis le casino de Biarritz le samedi soir. Grégoire l'accompagnait parfois au PMU, enfant, "c'était nos moments à nous". Dettes, huissiers ; la maison familiale a été saisie l'année de ses 14 ans et sa mère est partie avec les deux enfants, c'est là la séparation des parents. Il dit qu'il s'était juré "de ne jamais être comme lui" et qu'il s'est retrouvé "avec les mêmes lettres recommandées sur la table".
Il évoque aussi l'école : "j'étais le gamin qui ne tenait pas en place", souvent puni, un redoublement, un renvoi de quelques jours au collège. Il dit qu'il a toujours eu du mal à finir ce qu'il commence, à attendre, qu'il perd tout.
Je lui fais part de l'intérêt d'une évaluation d'un éventuel trouble de l'attention, déjà évoqué par le Dr DUCASSOU. Il est demandeur.
Transmis au médecin.
Il dit qu'il comprend mieux pourquoi il a "toujours eu besoin d'un truc qui va vite". Il fait le lien entre le PMU de son enfance et l'excitation des paris en direct, "c'était le même bruit dans la tête".
Il n'a pas revu son père depuis plusieurs années, ne souhaite pas le revoir pour l'instant.
Il se souvient des "jours de tiercé gagnant" où son père revenait avec des cadeaux, et des soirs où il ne revenait pas. Sa mère lui disait de ne jamais "parler des courses" à l'école. Il pleure pendant une partie de la séance, puis dit qu'il se sent "plus léger".

Observation psychiatrique de suivi du 07/11/2023 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 07/11/2023 à 20:30
Observations :
Vu ce jour
Abstinent de cocaïne depuis 7 mois. Alcool 2-3 verres le week-end. Pas de jeu, interdiction respectée, il dit ne pas avoir cherché à la contourner.
Thymie normalisée depuis environ un mois : plaisir retrouvé, sommeil 7 h, projets. EDC en rémission.
Thérapie de couple en cours depuis septembre, rapprochement avec son épouse, ils envisagent un retour à la maison "après les fêtes".
Éléments rapportés à la psychologue : père joueur pathologique (PMU, casino), saisie de la maison familiale et séparation des parents à ses 14 ans ; difficultés scolaires et agitation dans l'enfance. Plainte attentionnelle persistante malgré 7 mois

d'abstinence.
Plan de surendettement en cours d'instruction. Recherche d'emploi : formation envisagée.
Conclusions :
Évaluation d'un TDAH de l'adulte à organiser avec l'interne (Dr CAMPISTRON) : ASRS, DIVA, recueil auprès de la mère, bulletins scolaires.
Escitalopram 15 mg poursuivi.

Observation psychiatrique de suivi du 28/11/2023 (Urgence : Bas)

Validé par CAMPISTRON Solenne - Interne le 28/11/2023 à 19:50
Observations :
Vu ce jour pour évaluation TDAH (1re consultation)
Rappel : patient de 44 ans suivi depuis 01/2021 pour TU cocaïne sévère (début vers 25 ans, usage professionnel depuis 2014), abstinent depuis 04/2023 ; jeu pathologique (paris sportifs en ligne depuis la coupe du monde 2018) avec surendettement ; EDC en 2023 avec crise suicidaire ; licencié en 11/2022.
ASRS v1.1 : 6/6 items de la partie A positifs.
Enfance (selon le patient) : "pile électrique", bavard, oublis permanents, affaires perdues, devoirs jamais finis, redoublement de la 5e, renvoi de 3 jours en 4e pour s'être battu, punitions fréquentes. Scolarité "sauvée" au lycée par le sport. Pas de bilan à l'époque.
Adulte : désorganisation, procrastination, impulsivité (achats, paroles, conduite), recherche de sensations, ennui rapide, retards. Compensation au travail par l'hyperactivité et, depuis 25 ans, par la cocaïne ("ça me mettait droit").
DIVA 2.0 débutée : critères d'inattention 7/9 à l'âge adulte.
Thymie : euthymique, sommeil 7 h, pas de symptôme dépressif résiduel. Pas d'épisode d'élation spontanée en dehors des produits.
Consommations actuelles : pas de cocaïne depuis le 09/04, alcool 2 verres le samedi, pas de jeu. Tabac 8 cig/j.
Conclusions :
Forte suspicion de TDAH. Poursuite de la DIVA au prochain RDV. Contact de la mère (accord du patient) et bulletins scolaires si possible.

Entretien téléphonique du 12/12/2023 (Urgence : Bas)

Validé par CAMPISTRON Solenne - Interne le 12/12/2023 à 14:10
Observations :
Entretien téléphonique avec Mme LASSUDRIE Monique, mère du patient, avec l'accord de ce dernier.
Décrit un enfant "adorable mais épuisant", qui "ne tenait pas cinq minutes à table", "toujours dans la lune en classe", cahiers mal tenus, nombreux mots des enseignants dès le CP. Redoublement de la 5e "à cause du bazar à la maison" (dettes de son mari, huissiers). Renvoi temporaire en 4e après une bagarre. Elle cite un bulletin de CM2 : "intelligent mais ne se concentre pas".
Elle confirme spontanément le jeu de son ex-mari : "il a tout perdu aux courses, la maison aussi", séparation en 1993. Elle s'inquiète d'avoir appris que "Grégoire a fait pareil".
Elle enverra des bulletins scolaires si elle les retrouve.
Conclusions :
Hétéro-anamnèse en faveur de symptômes de TDAH présents dans l'enfance, avant 12 ans.

Observation psychiatrique de suivi du 09/01/2024 (Urgence : Bas)

Validé par CAMPISTRON Solenne - Interne le 09/01/2024 à 20:00
Observations :
Vu ce jour (2e consultation TDAH)
Est rentré vivre à la maison avec son épouse et les enfants le 06/01/2024. "On recommence doucement." Thérapie de couple poursuivie.
Fin de la DIVA 2.0 : inattention 7/9 et hyperactivité-impulsivité 6/9 à l'âge adulte ; inattention 8/9 et hyperactivité-impulsivité 7/9 dans l'enfance, concordant avec l'hétéro-anamnèse maternelle et deux bulletins scolaires (CM2, 5e) apportés par le patient. Retentissement professionnel, conjugal, financier.
Pas d'épisode maniaque ou hypomane retrouvé ; les épisodes d'excitation sont liés à la cocaïne.

Abstinent de cocaïne depuis 9 mois. Pas de jeu. Alcool réduit.
Diagnostics différentiels discutés : effets résiduels de la cocaïne (peu probable après 9 mois d'abstinence et symptômes présents dans l'enfance), trouble anxieux, trouble de l'humeur (EDC en rémission). Pas de contre-indication psychiatrique au méthylphénidate ; vigilance sur le risque de mésusage compte tenu des antécédents.
Conclusions :
TDAH de l'adulte, présentation combinée (validé avec le Dr DUCASSOU).
Discussion d'un traitement par méthylphénidate : ECG préalable, interrogatoire cardiovasculaire, TA, poids. RDV avec le Dr DUCASSOU en février.

Observation psychiatrique de suivi du 06/02/2024 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 06/02/2024 à 20:25
Observations :
Vu ce jour avant introduction éventuelle d'un psychostimulant.
ECG du 30/01 : rythme sinusal, 72/min, QTc 418, pas d'anomalie. TA 128/80. Poids 79 kg.
À l'interrogatoire cardiovasculaire détaillé, le patient rapporte, après une hésitation, un passage aux urgences de la Polyclinique fictive de Mérignac en 2017 pour une douleur thoracique "en barre" survenue après une nuit de cocaïne : ECG et troponine "normaux" selon lui, sorti le matin avec le conseil de "voir un cardiologue", ce qu'il n'a pas fait. Il dit qu'il n'en avait jamais parlé, à l'entrée il avait dit n'être "jamais allé aux urgences", "par honte, j'avais menti aux urgentistes sur la coke aussi".
Pas d'autre épisode de douleur thoracique, pas de palpitation, pas de malaise. Pas de mort subite familiale.
Le patient dit qu'il a "fait le ménage dans tous les mensonges", et qu'il ne pense pas qu'il en reste. Il comprend la nécessité de l'avis cardiologique, "même si j'ai hâte".
Conclusions :
Antécédent de douleur thoracique sous cocaïne aux urgences en 2017, jusqu'ici non connu.
Avis cardiologique demandé avant le méthylphénidate. RDV après la consultation.

Observation psychiatrique de suivi du 05/03/2024 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 05/03/2024 à 19:50
Observations :
Vu ce jour
Consultation de cardiologie le 26/02 : échographie cardiaque et épreuve d'effort normales, pas de contre-indication au méthylphénidate, surveillance TA et fréquence.
Abstinent de cocaïne depuis 11 mois, de jeu depuis janvier 2023. Alcool : 2 verres le week-end.
Information détaillée : risque de mésusage faible avec la forme LP, ordonnance sécurisée, délivrance fractionnée, contrôle TA/poids.
Le patient dit attendre beaucoup du traitement, "peut-être trop". Rappel que le traitement ne remplace pas le suivi psychologique.
Conclusions :
Introduction du méthylphénidate LP 18 mg le matin, augmentation prévue à 36 mg dans un mois selon tolérance.
Escitalopram 15 mg poursuivi. IDE dans 3 semaines.

Observation psychiatrique de suivi du 16/04/2024 (Urgence : Bas)

Validé par CAMPISTRON Solenne - Interne le 16/04/2024 à 19:35
Observations :
Vu ce jour
Méthylphénidate LP 18 mg depuis le 05/03 : amélioration partielle de l'organisation, effet qui s'estompe en début d'après-midi. Bonne tolérance (TA 128/80, FC 78, poids 78 kg).
Pas de craving de cocaïne accru, pas de jeu. Recherche d'emploi : formation de remise à niveau en gestion commerciale.
Conclusions :
Augmentation à 36 mg/j. Ordonnance sécurisée 28 j.
Dernier RDV avec moi (fin de semestre). RDV Dr DUCASSOU en juin.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation sociale du 21/05/2024 (Urgence : Bas)

Validé par TRESSENS Sabine - Assistante sociale le 22/05/2024 à 10:30

Point surendettement. Décision de la commission reçue en mars 2024 : mesures imposées sur 7 ans (84 mois), mensualité de 420 €, effacement partiel des intérêts, pas de nouveau crédit pendant la durée du plan, inscription au FICP.
M. LASSUDRIE a payé les deux premières échéances.
Retour au domicile conjugal depuis janvier : budget commun reconstruit avec son épouse, qui gère désormais les comptes (''c'est mieux comme ça'').
ARE jusqu'à l'été 2025. Formation de remise à niveau en cours, financée par France Travail.
Il me demande s'il doit déclarer son TDAH à un futur employeur : information donnée (pas d'obligation, RQTH possible mais non souhaitée).
Prochain RDV à sa demande.

Observation psychiatrique de suivi du 18/06/2024 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 18/06/2024 à 20:10

Observations :
Vu ce jour
Méthylphénidate LP 36 mg : ''le jour et la nuit'', termine ses tâches, moins d'impulsivité verbale à la maison selon son épouse. TA 132/84, FC 82, poids 77 kg. Sommeil correct.
Abstinent de cocaïne depuis 14 mois, pas de jeu. Alcool : 2-3 verres le samedi.
Thymie stable, euthymique.
Évoque la possibilité de réduire l'escitalopram : à rediscuter en fin d'année.
Il note aussi moins d'envie de jouer ''même devant un match''. Couple : thérapie poursuivie, ''on se parle''.
Conclusions :
Poursuite méthylphénidate LP 36 mg et escitalopram 15 mg.
RDV septembre.

Observation psychiatrique de suivi du 17/09/2024 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 17/09/2024 à 20:00

Observations :
Vu ce jour
Bonne rentrée familiale. Effet du méthylphénidate jugé insuffisant en fin de journée (retours de formation, devoirs des enfants : ''je redeviens une pile à 17h'').
TA 130/82, FC 84, poids 77 kg. Pas de palpitation, pas de douleur thoracique.
Pas de cocaïne, pas de jeu. Alcool stable.
Conclusions :
Augmentation du méthylphénidate LP à 54 mg/j. Surveillance TA par l'IDE dans un mois.
RDV décembre.

Observation IDE du 10/12/2024 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 10/12/2024 à 17:35

Entretien IDE. TA 130/80, FC 82, poids 77 kg. Méthylphénidate 54 mg depuis septembre, bien supporté, il dit que la formation se passe bien et qu'il a commencé à envoyer des candidatures. Urines négatives. Il est un peu inquiet pour les fêtes : une soirée d'anciens collègues est prévue le 21, il hésite à y aller. On en a parlé, il a fait une liste de ''plans de sortie''. Transmis.

Observation psychiatrique de suivi du 07/01/2025 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 07/01/2025 à 19:45

Observations :
Vu ce jour
Rechute de cocaïne le samedi 21/12/2024, lors d'une soirée d'anciens collègues de Médivia : ''deux traces, et puis toute la nuit'', environ 1,5 g, avec beaucoup d'alcool. Rentré à 6 h, en a parlé lui-même à son épouse le lendemain. Pas de reprise depuis, craving fort pendant une semaine. Pas de jeu, mais ''j'ai eu envie de parier sur le match du lendemain, pour la

première fois depuis longtemps".
Pas de signe dépressif. Il en tire des leçons : "plus de soirées avec cette équipe".
Méthylphénidate LP 54 mg bien toléré, TA 130/80.
Il souhaite arrêter l'escitalopram, euthymique depuis plus d'un an.
Il ajoute qu'il ne voulait pas "laisser passer la soirée" pour ne pas paraître "malade" devant ses anciens collègues, et qu'il était parti avec l'idée de ne boire que de l'eau.
Conclusions :
Rechute ponctuelle le 21/12/2024 (cocaïne, alcool), sans reprise.
Décroissance de l'escitalopram : 10 mg pendant un mois puis 5 mg, arrêt fin février.
RDV mars.

Observation psychiatrique de suivi du 04/03/2025 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 04/03/2025 à 20:40
Observations :
Synthèse après quatre ans de suivi.
Rappel : M. LASSUDRIE, 45 ans, ancien cadre commercial (Médivia, matériel médical), marié, deux enfants (Victor 13 ans, Capucine 10 ans). Suivi depuis janvier 2021.
Cocaïne : début vers 25 ans (2004) en contexte festif, usage professionnel et solitaire depuis 2014 avec perte de contrôle. Premier suivi en libéral (Dr ESTRABAUD) en 2015 avec 8 mois d'abstinence, nié à l'entrée et retrouvé dans le courrier du médecin traitant en 2022. Douleur thoracique sous cocaïne aux urgences en 2017, révélée en 2024. Cocaïne fumée quelques week-ends au printemps 2019. Au CSAPA : arrêt le 28/01/2021, rechute à l'été 2021 puis usage de week-end, nouvelle escalade d'avril 2022 à avril 2023 avec perforation septale (06/2022). Abstinence depuis l'hospitalisation d'avril 2023, une rechute ponctuelle le 21/12/2024.
Jeu : paris sportifs en ligne depuis 2017, majorés au confinement, révélés par l'épouse en janvier 2023, dettes de 41 500 €, interdiction ANJ depuis mai 2023, surendettement avec plan de 7 ans depuis mars 2024. Père joueur pathologique.
Alcool : usage quotidien associé jusqu'en avril 2023 (sevrage hospitalier), puis consommation modérée de week-end.
Psychiatrie : épisode dépressif en 2016 (paroxétine, médecin traitant) ; EDC de janvier à novembre 2023 avec crise suicidaire et intoxication le 09/04/2023, hospitalisation du 11 au 27/04/2023 ; escitalopram de mars 2023, en cours d'arrêt.
TDAH de l'adulte, présentation combinée, diagnostiqué en janvier 2024 ; méthylphénidate LP depuis mars 2024, 54 mg depuis septembre 2024.
Vie : licencié en décembre 2022 ; permis suspendu de décembre 2022 à juillet 2023 ; séparation du couple de janvier 2023 à janvier 2024, thérapie de couple ; chômage, formation.
Actuellement : escitalopram 5 mg, arrêt prévu dans 15 jours. Depuis le début février, "un verre ou deux tous les soirs" qui deviennent souvent 4 ou 5 : candidatures sans réponse, fin des droits au chômage en vue, ennui. Pas de cocaïne ni de jeu. Thymie correcte, un peu d'anxiété.
Tabac : 8-10 cig/j.
Entourage : épouse et enfants soutenants ; sœur toujours présente. Pas de procédure judiciaire en cours. Permis valide.
Traitements actuels : méthylphénidate LP 54 mg, escitalopram 5 mg. TA 130/82, FC 80, poids 77 kg.
Suivi : psychologue mensuelle (Mme POUDENX) depuis 2021, AS pour le plan de surendettement, IDE. Thérapie de couple en libéral depuis septembre 2023, en cours d'espacement. Le patient est le premier à rappeler les éléments qu'il avait tus : "j'ai mis deux ans à tout dire".
Perforation septale stable, pas d'épistaxis depuis 2023. Bilan cardiologique normal en février 2024.
Conclusions :
TU cocaïne en rémission prolongée. Jeu pathologique en rémission. TDAH traité. Reprise d'un usage quotidien d'alcool à surveiller.
Arrêt de l'escitalopram fin mars. Bilan GGT/CDT. Discussion d'un traitement de réduction à la prochaine consultation.
RDV fin mars, IDE dans 15 jours.

Observation IDE du 18/03/2025 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 18/03/2025 à 17:50
Entretien IDE. Alcool : 4 à 5 verres de vin tous les soirs depuis début février, il a compté sur l'appli que je lui avais conseillée, "ça fait 32 verres la semaine dernière, ça m'a fait un choc". Pas de verre le matin. GGT 64 (à 31 il y a un an),

CDT limite.
Il dit qu'il boit "parce qu'il s'ennuie et qu'il a peur de ne jamais retrouver de boulot". Sa femme lui a dit "je ne vais pas revivre ça". Je lui ai parlé de la naltrexone, il veut en parler au Dr DUCASSOU. TA 136/86. Transmis.

Observation psychiatrique de suivi du 25/03/2025 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 25/03/2025 à 19:30
Observations :
Vu ce jour
Usage quotidien d'alcool depuis début février 2025, 4 à 5 verres/j, sans signe de dépendance physique. Objectif de réduction.
Escitalopram arrêté comme prévu, pas de syndrome de sevrage, thymie stable.
Pas de cocaïne, pas de jeu.
Il dit que l'ennui est le principal déclencheur : journées vides, candidatures sans réponse. Son épouse s'inquiète, sans conflit. Pas de consommation matinale, pas de tremblement.
Conclusions :
Introduction de naltrexone 50 mg/j, à prendre une heure avant la situation à risque (approche de réduction). Information sur les opioïdes.
RDV avec l'interne en mai.

Observation psychiatrique de suivi du 20/05/2025 (Urgence : Bas)

Validé par DARRÉ Maxime - Interne le 20/05/2025 à 19:40
Observations :
Vu ce jour (nouvel interne, 1re rencontre)
Rappel : TU cocaïne sévère en rémission (abstinent depuis 04/2023, 1 écart 12/2024), jeu pathologique (paris sportifs) en rémission, TDAH sous méthylphénidate LP 54 mg, EDC 2023 en rémission, reprise alcool depuis 02/2025 sous naltrexone.
Naltrexone prise "presque tous les jours", nausées la première semaine. Alcool : 2-3 verres certains soirs, 4 jours sur 7, "jamais plus de 3", journal de consommation tenu.
Deux entretiens d'embauche ce mois-ci, dont un en seconde étape.
TA 128/82, FC 80.
Thymie euthymique depuis l'arrêt de l'escitalopram. Sommeil 6-7 h.
Conclusions :
Réduction nette de l'alcool. Poursuite naltrexone et méthylphénidate.
RDV juillet.

Observation IDE du 17/06/2025 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 17/06/2025 à 18:00
RDV non honoré. Message du patient en fin de journée : oubli, "j'étais à un entretien à Libourne". RDV redonné.
Ordonnance sécurisée de méthylphénidate renouvelée par le Dr DUCASSOU, envoyée par courrier à sa demande.

Entretien psychologique du 08/07/2025 (Urgence : Bas)

Validé par POUDENX Héloïse - Psychologue le 08/07/2025 à 18:40
Séance de bilan, à quatre ans et demi de suivi, à la demande de M. Lassudrie qui veut "espacer".
Il mesure le chemin : il y a deux ans il "dormait chez sa sœur avec des dettes partout", aujourd'hui il vit avec sa famille, rembourse, a "compris comment il fonctionne".
Il parle du diagnostic de TDAH comme d'un "soulagement mêlé de colère" : il se demande ce qu'aurait été sa vie avec un diagnostic à 10 ans, et pense à son père ("peut-être que lui aussi").
Il évoque l'alcool de ce printemps comme "le dernier produit qui restait", le relie à l'ennui.
Il vient d'obtenir une promesse d'embauche : commercial sédentaire dans une PME de matériel agricole à Libourne, CDI, début au 1er septembre. Peur de "redevenir le commercial d'avant". Travail sur les limites (horaires, soirées clients, alcool en salon).
Proposition : séances mensuelles à partir de la rentrée.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Observation psychiatrique de suivi du 09/09/2025 (Urgence : Bas)

Validé par DARRÉ Maxime - Interne le 09/09/2025 à 20:05

Observations :
Vu ce jour
A commencé son nouvel emploi le 01/09/2025 (commercial sédentaire, CDI, période d'essai de 4 mois). Fatigué mais content. Trajets en voiture 45 min.
A arrêté de lui-même la naltrexone à la mi-août, pendant les vacances, "je n'en avais plus besoin". Alcool : quelques verres le week-end seulement depuis l'été.
Méthylphénidate LP 54 mg, efficace, TA 132/84. Appétit diminué le midi.
Pas de cocaïne, pas de jeu.
Il dit qu'il a refusé une soirée de bienvenue "par prudence" et qu'il ne parle pas de son parcours au travail.
Conclusions :
Arrêt de la naltrexone en août 2025 (initiative du patient), validé. Poursuite méthylphénidate.
RDV décembre avec le Dr DUCASSOU (fin de mon semestre en octobre).

Entretien téléphonique du 14/10/2025 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 14/10/2025 à 09:40

Appel de la pharmacie : le patient a présenté son ordonnance de méthylphénidate avec 5 jours de retard, la pharmacienne demande si elle peut délivrer la totalité. Vu avec le Dr DUCASSOU : oui, délivrance du reste de l'ordonnance (chevauchement autorisé). Le patient dit avoir "oublié avec le boulot". Pas d'autre souci.

Observation psychiatrique de suivi du 02/12/2025 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 02/12/2025 à 20:20

Observations :
Vu ce jour
Bonne adaptation au nouveau poste, période d'essai "validée en fin de mois normalement", bons retours de son responsable. Horaires tenus, pas de soirées clients.
Rechute du jeu en novembre : sur un site de paris étranger non couvert par l'interdiction ANJ, "trouvé par une pub sur un réseau social", paris sur le foot pendant environ 10 jours, perte de 600 €. Il s'est arrêté seul après une nuit à "se refaire", en a parlé à son épouse puis l'a dit spontanément ici. Honte, mais "je n'ai pas caché, c'est déjà ça".
Pas de cocaïne. Alcool : 2-3 verres le week-end.
Méthylphénidate LP 54 mg, TA 134/84, poids 74 kg (-3 kg depuis l'été). Il dit manger peu à midi.
Tabac : 10 cig/j, souhaite arrêter en janvier.
Il dit avoir été "piqué" par la publicité un soir de fatigue, après une journée difficile, en se disant "un seul pari, pour voir".
Conclusions :
Rechute brève du jeu en novembre 2025, arrêtée.
Logiciel de blocage des sites de jeux à installer sur ses appareils (voir avec M. GUICHENEY). Varénicline à prévoir en janvier, RDV IDE tabacologie.
RDV mars.

Observation éducateur du 16/12/2025 (Urgence : Bas)

Validé par GUICHENEY Cyril - Éducateur spécialisé le 16/12/2025 à 17:30

Entretien à la demande du Dr DUCASSOU après l'épisode de jeu de novembre.
On a installé ensemble un logiciel de blocage des sites de jeux et de paris sur son téléphone, son ordinateur et la tablette familiale ; son épouse garde le code. On a aussi désactivé les notifications des applis de résultats sportifs. Il rit : "je redeviens un supporter normal".
Il me reparle du groupe de 2022, il dit qu'à l'époque il "jouait déjà tous les soirs" pendant que je lui parlais de la coke, et qu'il pariait parfois pendant les pauses du groupe. Je lui dis que je m'en souviens, du "score du match".
Proposition : il peut me rappeler à tout moment en cas d'envie de jouer.

Observation IDE du 13/01/2026 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 13/01/2026 à 18:10

Consultation de tabacologie. Fume 10 à 12 cigarettes par jour depuis l'âge de 16 ans, plus en voiture et après les repas. Fagerström 5. CO expiré 18 ppm. Plusieurs fois "presque arrêté" (patchs à l'hôpital en 2023) mais repris "dès que ça allait mieux".
Motivation : ses enfants (Capucine lui cache ses paquets), le sport, "le dernier truc à régler".
Varénicline prescrite par le Dr DUCASSOU : début ce jour, schéma de titration expliqué, date d'arrêt fixée au 20/01. Effets indésirables expliqués (nausées, rêves). TA 132/84. Méthylphénidate inchangé.
RDV dans 3 semaines.

Entretien psychologique du 10/02/2026 (Urgence : Bas)

Validé par POUDENX Héloïse - Psychologue le 10/02/2026 à 19:00
Bilan psychologique, cinq ans de suivi, rédigé à la demande du Dr DUCASSOU pour la synthèse d'équipe.
M. Lassudrie, 46 ans, est suivi en psychothérapie depuis février 2021, tous les 15 jours puis de façon hebdomadaire après l'hospitalisation d'avril 2023, mensuelle depuis septembre 2025.
Pendant les deux premières années, le travail a porté sur la cocaïne et sur une image de soi entièrement adossée à la performance professionnelle. Ce travail a été en partie faussé par ce qui n'était pas dit : le jeu, les dettes, un suivi antérieur. Le patient le formule lui-même : "je vous racontais une version présentable". La révélation par son épouse en janvier 2023 a été vécue comme une catastrophe puis comme une libération ; elle a précédé la période la plus grave (épisode dépressif, crise suicidaire d'avril 2023).
À partir de l'automne 2023, l'histoire familiale a pu être abordée : un père joueur, des dettes, la saisie de la maison et la séparation des parents à ses 14 ans, l'enfant qui accompagnait son père au PMU et vivait ces moments comme "nos moments à nous". Le jeu à l'âge adulte prend sens dans cette loyauté et ce rejet mêlés. Le diagnostic de TDAH (janvier 2024) a permis une relecture moins culpabilisante de son parcours scolaire et de son besoin de stimulation, sans servir d'excuse : "ça explique, ça n'efface pas".
Aujourd'hui : relation de couple réinvestie, place de père plus présente (il accompagne Victor au rugby), activité professionnelle plus modeste mais stable, remboursement des dettes tenu. Les points de vulnérabilité restent l'ennui, la honte qui pousse à cacher (l'épisode de jeu de novembre 2025 est le premier qu'il a dit d'emblée), et les situations de "fête" liées à son ancienne vie professionnelle.
Il signale aujourd'hui avoir arrêté la varénicline au bout de quatre jours en janvier (nausées) et avoir "rechuté" sur la cigarette le 22/01 ; il veut reprendre "avec un vrai rendez-vous".
Proposition : poursuite mensuelle, travail sur la prévention de la rechute à partir des situations de fête et sur le deuil anticipé de son père, malade.
Sur le plan des consommations, il dit ne plus penser à la cocaïne "que dans les fêtes", n'a pas joué depuis novembre, boit peu. Le tabac est le dernier objectif qu'il se fixe.
Points d'appui : un discours plus authentique, une capacité nouvelle à demander de l'aide (sa sœur, son épouse, l'équipe), l'activité physique régulière. Le patient formule le souhait d'être "un jour un ancien patient", tout en disant qu'il veut "garder un fil" avec le centre.

Observation IDE du 17/02/2026 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 17/02/2026 à 17:45
Revu en tabacologie. M. LASSUDRIE avoue qu'il avait arrêté la varénicline au bout de quelques jours en janvier à cause des nausées, il n'a pas osé me le dire au téléphone. Reprise de la varénicline ce jour, à prendre au milieu du repas, nouvelle date d'arrêt fixée au 20/02. CO 16 ppm. Il est motivé, a prévenu ses collègues. Transmis au Dr DUCASSOU.

Observation psychiatrique de suivi du 17/03/2026 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 17/03/2026 à 20:00
Observations :
Vu ce jour
Arrêt du tabac depuis le 20/02/2026 sous varénicline (reprise le 17/02 après un premier essai interrompu en janvier). Quelques envies, nausées légères.
Insomnie d'endormissement depuis l'hiver, appétit faible, poids 72 kg (79 kg en 2024). Sous méthylphénidate LP 54 mg, efficacité jugée bonne mais "trop fort l'après-midi".
Pas de cocaïne depuis le 21/12/2024, pas de jeu depuis novembre. Alcool : week-end, 2 verres.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Son père, à Pau, a un cancer du poumon métastatique, il s'y rend un week-end sur deux.
Il dit que l'arrêt du tabac est "plus dur que la coke, parce que c'est partout". Il court trois fois par semaine.
Conclusions :
Diminution du méthylphénidate LP à 36 mg/j. Poursuite varénicline jusqu'à 12 semaines.
RDV juin.

Observation IDE du 12/05/2026 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 12/05/2026 à 10:20
RDV IDE annulé par le patient (déplacement professionnel). Dit au téléphone avoir fini la varénicline "il y a quelques semaines", toujours sans tabac, "je cours deux fois par semaine". RDV reporté au mois de juin.

Observation sociale du 23/06/2026 (Urgence : Bas)

Validé par TRESSENS Sabine - Assistante sociale le 23/06/2026 à 11:20
Point annuel. Plan de surendettement respecté sans incident depuis mars 2024 (28 échéances de 420 € réglées). Salaire stable depuis septembre 2025, période d'essai validée fin décembre 2025. Le couple a renégocié l'assurance du crédit immobilier.
M. LASSUDRIE demande s'il peut solder le plan plus tôt avec une prime : information donnée sur la demande de révision auprès de la commission. Pas de nouveau crédit souscrit.
Il va souvent à Pau voir son père, "ce n'est plus qu'une question de semaines".
Fin du suivi social régulier proposée, recontact possible à tout moment : d'accord.

Entretien téléphonique du 21/07/2026 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 21/07/2026 à 12:45
Observations :
Appel du patient : son père est décédé le 16/07/2026 à Pau. Obsèques hier. Il dit avoir eu "une envie énorme" de cocaïne le soir, il a appelé sa sœur et est resté avec elle. Il a bu "pas mal de whisky" le soir des obsèques, "mais pas plus". Pas d'idée suicidaire, se dit triste "mais pas comme en 2023".
Conclusions :
Deuil. Pas de reprise de cocaïne. RDV avancé à septembre au retour de vacances, psychologue en août, numéro du 3114 rappelé.

Observation psychiatrique de suivi du 15/09/2026 (Urgence : Bas)

Validé par DUCASSOU Bérangère - Psychiatre addictologue le 15/09/2026 à 20:10
Observations :
Vu ce jour
Deux mois après le décès de son père. Tristesse, souvenirs mêlés, il a trié avec sa sœur des papiers où il a trouvé des reconnaissances de dettes de son père datant des années 1990, "ça m'a fait drôle". Pas de symptôme dépressif caractérisé, sommeil correct.
Pas de cocaïne depuis le 21/12/2024. Pas de jeu, logiciel de blocage toujours actif. Alcool : 2 verres le samedi, une alcoolisation le soir des obsèques. Tabac : abstinent depuis le 20/02.
Méthylphénidate LP 36 mg : bon équilibre, poids 75 kg, TA 128/80.
Travail : bonne année, prime de fin d'exercice, refuse un poste itinérant "pour ne pas retomber dans les hôtels".
Il évoque l'idée d'espacer les rendez-vous, "mais pas de les arrêter". Il souhaite garder la psychologue une fois par mois.
Conclusions :
TU cocaïne en rémission prolongée. Jeu en rémission. TU alcool en rémission. Tabac en sevrage. TDAH équilibré.
Poursuite du méthylphénidate LP 36 mg. RDV tous les 3 mois.

Observation IDE du 13/10/2026 (Urgence : Bas)

Validé par LAFARGUE Fanny - IDE le 13/10/2026 à 18:00
Entretien IDE de suivi. TA 126/80, FC 76, poids 75 kg. Toujours sans cigarette depuis février, CO 2 ppm, il est très fier et me montre l'appli qui compte les euros économisés, "ça rembourse un bout du plan". Urines négatives. Méthylphénidate pris tous les matins, délivrance OK.

HISTORIQUE DES OBSERVATIONS

Il me dit que Victor, 15 ans, lui a posé des questions sur la cocaïne après une soirée de son lycée, il lui a "tout raconté, en version courte". Il demande s'il peut l'emmener un jour à la consultation jeunes consommateurs "juste pour parler".
Informations données.
Prochain RDV médical en décembre.